

ملاحظات : ---

شعار الجمهورية

--

Name: اسماء السيد عطيه عبدالله National ID: 27809161500408	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



اسماء
انسيد عطيه عبدالله
ش الاهرام
مركز الصف - الجيزة

١٩٧٨/٠٩/١٣
٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨
LI6983146



٢٠٢٥/٠٩/٢٧ ٢٧٨٠٩١٦١٥٠٠٤٠٨

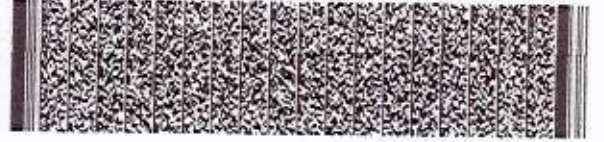
حاصله على دبلومة زراعي

أنثى مستلمة متزوجة
على فوزى السيد ابوالخير

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/٠٥



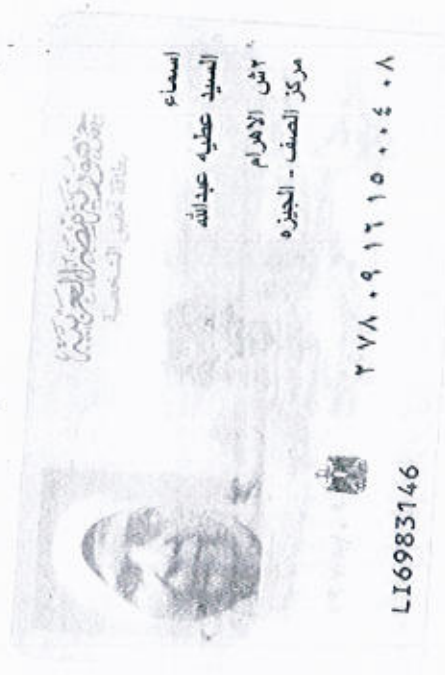
١



Name: <u>اسماء السيد عطيه</u>		
MR. : <u>266</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها was CT3 N1 , triple positive , 21/3/2022-->LT MRM POST NACT NO RESIDUAL VIABLE,,IDC GII...LN 0/16 FREE RESECTION MARGIN...CPR STAGE YPTO YPNO (MDT OUTCOME to complete 1 year of HP ,PORT , tamoxifen) patient recieved tamoxifen for 28 months , shifted to arimidex to recieve zoladex + arimidex today Referred from the oncology clinic >> Skin benign looking polyp at the Rt inner thigh appeared 2 m ago gradually increasing in size >> for MDT sm 8/2025 left operative bed mass birads 4 b biopsy fat necrosis no maluignancy on exam nad for zoladex zometa arimidex		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		



DMS
سواركن البن والصور
تعليل وضوضها ت





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
صحة
مصر

02/25/2026

MDT FORM

Name:	Asmaa Sayed Atiah .	MRN:	266
Age:	47 Y	ID:	CVN-91710--2-1
Menopausal Sta		Phone:	01149086653
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	MF , Hx of it MRM post NACTH now on hormonal ttt	Reason Of MDT:	new non breast lesion presentation

Clinical Data:

BX:		R		L			
ER:		PR:		HER2:		KI67:	

Sonomammography:Mets Workup:History:

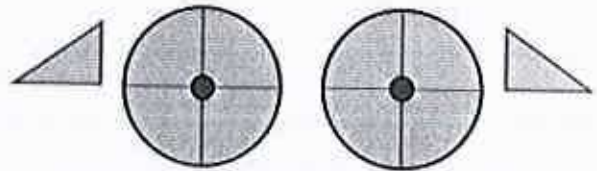
Skin benign looking polyp at the Rt inner thigh appeared 2 m ago gradually increasing in size

Recommendations:

for possibility of ex bx

MDT Outcome & Plan

for excision



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ نيل حسن	د/ عبد السلام شادي	د/ نزيهين ومضان			



Patient Name	: الأستاذ / اسماء السيد عطيه	Request No.	: 13009384
Patient No.	: 27809161500408	Request Date	: 13/03/2023
Path No.	: 769/23	Verification Date	: 21/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 25x17x6.5 cm with covering skin ellipse measured 20x16 cm. Axilla measured 5x4x2cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 9x6 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 1.5cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: 16 L.Ns up to 1cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual viable tumour tissue in previously diagnosed Invasive duct carcinoma GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Skin involvement: Free nipple and areola.
- * Lymph node involvement: Negative 0/16.
- * Resection Margins: Free.
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, MRM specimen:

- * No residual viable tumour tissue in previously diagnosed Invasive duct carcinoma GII.
- * Free nipple and areola.
- * Lymph node were Negative 0/16.
- * Free resection Margins.
- * Complete pathological response to therapy.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/04/2023 09:21:25

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / اسماء السيد عطيه	Request No.	: 13009384
Patient No.	: 27809161500408	Request Date	: 13/03/2023
Path No.	: 769/23	Verification Date	: 21/03/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Stage: ypT0 , ypN0.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Heba Hassan.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 08/04/2023 09:21:25

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

خريطة رقم (4) - الدور الثاني - مبنى رقم (987) - المستشفى القلبي - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor, Building No. 987, Nile Corniche - Min El Qadima Cairo, Egypt

Registered by : .marwa mohamed yousse

طبعة رقم ١٤٠٢ - الطبعة الأولى - ص ٩٥٧ - رقم (٩٨٦) - دار النشر: مكتبة - مطبعات - الطباعة - مصر
Room No. ١٤٠ - First Floor-Building No. ٩٨٦ - Nita Cinema - Mena El Qasaba - Cairo

Request No.	13001987
Request Date	10/09/2022
Verification Date	26/09/2022
Financial Category	اورام دار السلام - مبادرہ
Department	Out Patient

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Invasive duct carcinoma GII with Duct carcinoma insitu component.
- IPT :
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- HER-2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Prof. Amal Hareedy.
Dr.Menna Nabil.

Verified by :

Printing Date : 26/09/2022 14:52:44

Page 2 of 2

Printed By : hermal

Patient Name: Asmaa Al Sayed Ateya Abd Allah	Date : 07/12/2024
Exam: C.T CHEST	Age: 46 Year(s)
Medical ID: 3815/2022	Pat. ID: 18643

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:-

**Comparing to last study done at 9/3/2023, The current study showing:*

Findings:

- * Evidence of left breast MRM with reconstruction and left axillary intervention showing operative bed thickened sheets, studded with scattered irregular isodense lesions, largest measures 2.5x1.5cm seen at lateral aspect of the scar, some of them showing central fat density likely post-operative changes.
- * Right breast is partially out of field.
- * No pulmonary parenchymal masses, consolidation or cavitary lesions.
- * Few subcentimetric mediastinal lymph nodes.
- * No evidence of pleural effusion.
- * Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- * Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- * Stable DS ,8 and 9 tiny faint sclerotic lesions.
- * Upper abdominal cuts are unremarkable.
- * Still noted right sided porta-cath.

OPINION:

- * ***Evidence of left MRM with reconstruction and operative bed post-operative changes***
- * ***No CT evidence of chest infection or pulmonary metastatic lesions.***

Dr. Walid Mohamed, M.D.

التاريخ: 11.10.2022

الاسم: اسماء السيد عطيه

Tc-99m MDP DUAL PHASE BONE SCAN:**History**

- 44-year-old lady presented with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Procedure:

- Early blood pool and late osseous whole body scans were obtained at 5 minutes and 2 hours post tracer injection, respectively.

Findings:

- The scanned skeleton is free from abnormal active or cold foci that would account for serious or malignant/metastatic bone lesions.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- The early blood pool scans are unremarkable.

Opinion:

- No metastatic skeletal lesions detected on scintigraphic basis.

Much obliged,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Call Center **19656**

Patient Name: Asmaa Al Sayed Atteya Abd Allah	Date : 08/09/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 1897	

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication: Left breast mass

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

LEFT BREAST:

- Regional left breast asymmetry harboring malignant spiculated dense mass lesions and malignant pleomorphic calcifications measuring collectively about 1.7x10 cm.
- Increase of areolar skin thickness
- Complementary U/S revealed multiple ill defined malignant looking hypoechoic solid mass lesions with infiltrated intervening parenchyma extending from 11 to 4 o'clock surrounding by area of altered parenchyma and showing anterior ductal extensions reaching to the nipple, the largest mass lesion located at 2-3 o'clock measuring about 5x3.5 cm. Color Doppler showed abnormal internal vascularity.
- Multiple pathological axillary (level I and II) lymph nodes with effaced fatty hila and uniform increase of cortical thickness.
- Indeterminate supraclavicular lymph nodes

RIGHT BREAST:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- benign macrocalcifications
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Retroareolar dilated ducts.No cystic or solid mass lesions by U/S.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Left breast locally advanced multicentric malignant process with pathological axillary lymph nodes for histopathological correlation(BIRADS 5)
- Right breast benign findings (BIRADS 2)

Yours truly

Dr/Asmaa Zeinhom, MSC.



جهاز الإصدار: فرع الجيزة

تاريخ الإصدار: 2023-7-4

إلى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقاً لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقاً لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) اسماء السيد عطيه عبد الله بطاقة رقم 27809161500408
وطبقاً إلى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون أي مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكراً

تاريخ الطباعة: 2023-7-4



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مستمل 834121



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Name : Asmaa El-Sayed Atieh Abdallah

Date : 10-09-2026 08:22

Branch : Dokki

Medical No. : 458564

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفىات

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

Clinical Indication: 48-year-old female with breast carcinoma. Referred for staging/follow-up skeletal evaluation.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of 99mTc-MDP.

Findings:

- Mild low-grade tracer uptake is noted at the lower lumbar spine (L4–L5 level)—favoring benign degenerative/spondylotic changes.
- The remainder of the axial and appendicular skeleton shows homogeneous symmetric physiological tracer distribution without focal lesions.
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- Equivocal low-grade L4–L5 uptake, most consistent with benign degenerative disc disease/spondylosis, for radiological validation.
- No definitive scintigraphic evidence of skeletal metastases.

Dr. Alaa Nagi

MD Nuclear Medicine